

“永信” 非炎鉀糖衣錠 50 毫克

VOREN-K SUGAR COATED TABLETS 50MG "YUNG SHIN"

衛署藥製字 第 044403 號

須由醫師處方使用

版本日期 2024-08-22

心血管栓塞事件：

1. NSAIDs藥品會增加發生嚴重心血管栓塞事件之風險，包括心肌梗塞和中風，且可能為致命的。此風險可能發生在使用該類藥品的初期，且使用藥品的時間越長，風險越大。
2. 進行冠狀動脈繞道手術(Coronary artery bypass graft, CABG)之後14天內禁用本藥。

1 性狀

1.1 有效成分及含量

每錠中含：Diclofenac Potassium.....50mg

1.2 賦形劑

Microcrystalline Cellulose、Calcium Phosphate Dibasic 2H₂O、Polyvinylpyrrolidone、Sodium Starch Glycolate、Sodium Lauryl Sulfate、Magnesium Stearate、Colloidal Silicon Dioxide、Talc、Hydroxypropylmethyl cellulose、Sucrose、Glycerine、Poloxamer、Sunset Yellow FCF Aluminium Lake、Calcium Carbonate、Titanium Dioxide、Potato Starch。

1.3 劑型

糖衣錠。

1.4 藥品外觀

橙紅色圓形糖衣錠，一面印有 YSP

59 字樣。



2 適應症

緩解發炎及因發炎反應引起之疼痛。

3 用法及用量

3.1 用法用量

為降低不良反應之風險，應使用最低有效劑量，並作為期最短之治療。

每日最大劑量不建議大於100 mg。症狀較輕及14歲以上青少年每日劑量為：75~100 mg；前述用量須分2~3次投予。

依症狀學來說，應在症狀一出現時便開始治療，並持續數天。

最好在飯前與液體一起投予Diclofenac Potassium錠劑。

本品不建議使用於兒童。兒童應採滴劑或栓劑治療。

老年病患（65歲及以上）：一般而言不用調整起始劑量，然老年患者用藥應謹慎，特別是對身體

虛弱或體重過輕之老年患者。

4 禁忌

(依文獻記載)

- 重症之血液異常患者。
- 重症之肝障礙患者。
- 重症之腎障礙患者(GFR <15 mL/min/1.73 m²)。
- 已知對Diclofenac成分或其賦形劑過敏之患者禁用。
- 活性消化性潰瘍、出血或穿孔患者；具NSAIDs相關腸胃道出血或穿孔病史者；具反覆發作之消化性潰瘍或出血病史者。
- 服用aspirin或其他NSAIDs之後曾發生氣喘、血管性水腫、蕁麻疹或其他過敏反應之患者禁用（即NSAID誘發之交叉反應）。此類患者對NSAIDs曾有嚴重、極少數致死的過敏反應(anaphylactic-like reactions)發生之報告。
- 進行冠狀動脈繞道手術(Coronary artery bypass graft, CABG)之後14天內禁用本藥。
- 懷孕第三期婦女禁用本藥。

5 警語及注意事項

(依文獻記載)

5.1 警語/注意事項

5.1.1 心血管作用

若使用包括Diclofenac在內的非類固醇抗發炎藥(NSAID)，尤其是長期以高劑量治療時，可能會微幅增加嚴重心血管血栓事件（包括心肌梗塞和中風）的危險性。

Diclofenac Potassium的治療一般不建議用於確認罹患心血管疾病（鬱血性心臟衰竭、確診之缺血性心臟病、周邊動脈疾病）或高血壓控制不良的患者。若有需要，確認罹患心血管疾病、高血壓控制不良或具心血管疾病重要危險因子（例如高血壓、高血脂、糖尿病、吸菸）的患者應當經過慎重考慮後，才接受Diclofenac Potassium治療。

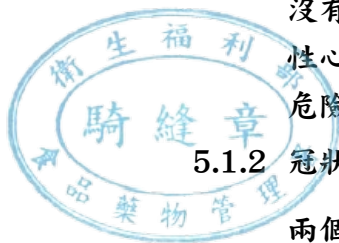
由於Diclofenac對心血管疾病的風險可能會隨著劑量和接觸時間而增加，故應以最低有效每日劑量儘可能在最短的時間內使用。當治療持續超過4週，應定期重新評估病人對緩解症狀的需要和對治療的反應。

針對可能無預警發生的嚴重動脈栓塞事件，患者對其徵兆和症狀應該保持警覺（如胸痛、呼吸急促、無力、口齒不清）。一旦發生，應指示患者立即就醫。

栓塞性心血管事件(Cardiovascular Thrombotic Events)

使用非類固醇類消炎藥治療可能使發生嚴重而可能致死之栓塞性心血管事件、心肌梗塞與中風的危險性增加。統合分析(Meta-analysis)和藥物流行病學資料指向Diclofenac的使用與動脈栓塞事件風險的些微增加有關（例如心肌梗塞），特別是高劑量（每日150毫克）和用於長期治療的情況下。

對於患有心血管疾病或具有心血管疾病危險因子的病人應使用最低有效劑量，並作為期最短的治療。病人應被告知嚴重心血管毒性的徵象與症狀，及萬一發生時所應採取的步驟。



沒有一致的證據證明同時使用aspirin能夠減少使用非類固醇類消炎藥時的嚴重栓塞性心血管事件風險。而同時使用aspirin與Diclofenac確實會增加嚴重胃腸道事件的危險性。

5.1.2 冠狀動脈繞道手術(CABG)後

兩個大型對照性臨床試驗中，發現選擇性COX-2之非類固醇類消炎藥在CABG手術後10~14天用於止痛，會增加其心肌梗塞和中風之發生率。所以在進行冠狀動脈繞道手術之後14天內禁用NSAID。

高血壓

投予非類固醇類消炎藥（包括Diclofenac在內）治療可能導致新的高血壓發病或使原有的高血壓惡化。使用thiazides利尿劑或環利尿劑的病人，在服用非類固醇類消炎藥期間對這些利尿劑的反應可能會減弱。對於高血壓之病人應謹慎投予Diclofenac，治療期間應密切監測血壓。

5.1.3 最近發生心肌梗塞的病人

觀察性研究顯示，在心心肌梗塞後使用NSAIDs藥品，在用藥第一週時，出現再梗塞、心血管相關死亡及整體死亡率等情形皆增加。研究亦顯示，心肌梗塞後使用NSAIDs者，其第一年死亡率為20/100人/年，而未使用NSAIDs者之死亡率則為12/100人/年。雖然使用NSAIDs者第一年後之死亡率逐年下降，但其後4年內之死亡率仍相對較高。因此，應避免使用本藥品於最近曾發生心肌梗塞的病人，除非經評估使用藥品之效益大於再發生心血管栓塞事件之風險。若本藥品使用於近期發生心肌梗塞的病人，應嚴密監視是否出現心肌缺血之症狀。

5.1.4 充血性心衰竭與水腫

隨機分派研究結果顯示，使用COX-2選擇性抑制劑及非選擇性NSAIDs藥品治療的病人發生心臟衰竭住院的比例為安慰劑組的兩倍。且在觀察性研究亦發現，有心臟衰竭的病人使用該類藥品，其心肌梗塞、因為心臟衰竭住院及死亡等情形皆增加。有些使用NSAIDs藥品的病人被觀察到有水分滯留及水腫等情形。因此使用本藥品可能會使一些藥品之心血管作用變得不明顯，例如diuretics、ACE inhibitors或angiotensin receptor blockers (ARBs)。因此，應避免使用本藥品於嚴重心臟衰竭的病人，除非經評估使用之效益大於心臟衰竭惡化之風險。若本藥品使用於嚴重心臟衰竭的病人，應嚴密監視是否出現心臟衰竭惡化之症狀。

5.1.5 胃腸道作用－胃腸潰瘍、出血及穿孔之危險性

非類固醇類消炎藥（包括Diclofenac在內）可能引起胃、小腸或大腸發炎、出血、潰瘍及穿孔等嚴重而可能致死之腸胃道不良反應。接受非類固醇類消炎藥治療的病人隨時可能出現這些嚴重的不良事件，且不一定有預警症狀。此現象在老年人通常會更為嚴重。服用Diclofenac的病患中，少數會發生胃腸出血或潰瘍之現象，此時應停止給藥。



對於有消化性潰瘍疾病或胃腸道出血病史之病人應謹慎投予。其他會增加使用非類固醇類消炎藥治療時發生胃腸道出血的危險因子包括同時使用口服皮質類固醇或抗凝血劑、長期使用非類固醇類消炎藥、吸煙、喝酒、年長及整體健康狀況不佳等。為了降低胃腸道不良反應的潛在危險，病人應使用最低有效劑量，並作為期最短的治療。

非類固醇類消炎藥（包括Diclofenac）可能提高胃腸道術後吻合口滲漏(anastomotic leak)的風險。在胃腸道手術後若需使用Diclofenac Potassium，應提高警覺並建議進行密集的醫療監測。

5.1.6 肝臟作用

投予Diclofenac治療期間可能發生一種或多種肝功能指數升高的現象。持續治療時，這些檢驗值異常可能會惡化、保持不變或僅為短暫的現象。依據上市後藥物安全監測報告，Diclofenac引起之肝毒性不良反應包括肝臟壞死、黃疸、猛暴性肝炎（無論具有黃疸與否）及肝衰竭。其中一些通報案例導致死亡或肝臟移植。長期使用Diclofenac治療的病人應定期檢測肝臟轉氨酶(transaminases)，依據臨床試驗數據和上市後經驗，應於治療後的第4到第8週內進行檢測。然而，嚴重肝毒性不良反應可能發生在以Diclofenac治療的任何時間。

若肝功能指數異常的情形維持或惡化，或出現與肝病一致的臨床徵象與症狀，或出現全身性反應（如嗜伊性白血球增多、皮疹、腹痛、腹瀉、褐色尿液等）時應立即停藥。為了降低肝臟不良反應的潛在危險，病人應使用最低有效劑量，並作為期最短的治療。同時投予具有潛在肝毒性的藥物（例如抗生素、抗癲癇藥）治療時須特別注意。

5.1.7 腎臟作用

長期投予非類固醇類消炎藥可能導致腎乳頭壞死及其他腎臟損傷。對於發生這類反應的高危險族群（年長者、腎功能受損、心衰竭、肝功能不全及使用利尿劑與ACE抑制劑的病人）應謹慎投予。

重症腎臟疾病

目前之對照性臨床試驗中尚未有關於重症腎臟疾病病人使用Diclofenac的資料，因此不建議此類病人使用。若必須開始Diclofenac治療，建議應該密切監測病人的腎功能。

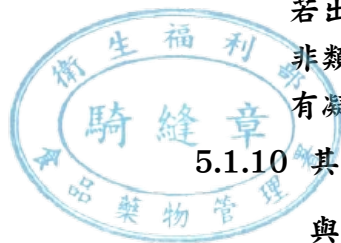
5.1.8 皮膚反應

非類固醇類消炎藥（包括Diclofenac在內）可能引發嚴重而可能致死的皮膚不良反應，例如剝落性皮膚炎、史蒂文生氏-強生症候群(SJS)和毒性表皮壞死溶解(TENS)。一旦出現皮疹或其他過敏徵象時應立即停藥。

治療早期，病患這些副作用的風險似乎最高，在大部分案例中，這些副作用會發生在治療第一個月。在第一次出現皮疹、黏膜病變或任何其他高敏感性的徵兆出現時，應該中斷Diclofenac的治療。

5.1.9 血液作用

接受非類固醇類消炎藥治療的病人有時會發生貧血。長期使用Diclofenac治療的病人



若出現任何貧血或失血的徵象或症狀，應進行血紅素及血比容之檢測。

非類固醇類消炎藥會抑制血小板凝集，某些病人可能出現出血時間延長的情形。患有凝血疾病或正在使用抗凝血劑的病人應密切監測血小板功能。

5.1.10 其他

與其他NSAIDs一樣，首次服用本品的病患中，少數可能產生過敏反應，包括過敏性及類過敏反應。

與其他NSAIDs一樣，因其藥效動力學特性，Diclofenac可能會遮蔽感染症之徵候及症狀。

- 5.1.11 懷孕30週以上之孕婦使用非類固醇抗發炎藥(NSAIDs)可能導致胎兒心臟導管過早閉合和肺動脈高壓，應避免使用。懷孕20週或以上之孕婦使用非類固醇抗發炎藥(NSAIDs)可能導致胎兒腎臟功能不全(fetal renal dysfunction)、羊水過少(oligohydramnios)，甚至新生兒腎臟損傷(renal impairment)。若醫療專業人員認為病人有必要於孕期20至30週時使用非類固醇抗發炎藥，則應限制以最低有效劑量及最短期間治療。若治療時間超過48小時，醫療專業人員應考慮使用超音波監測羊水狀態。

5.3 操作機械能力

患者若有頭昏或其他中樞神經障礙之現象，包括視力障礙，則不應駕車或操作機械。

5.4 實驗室檢測

實驗室檢驗：由於嚴重的胃腸道潰瘍及出血可能沒有預警症狀，醫師應監測是否有胃腸出血的徵象或症狀。長期使用非類固醇類消炎藥的病人，應定期做全血球計數(CBC)及生化檢查。若肝功能或腎功能檢驗異常的情形維持或惡化，應立即停藥。

5.5 其他注意事項

- 5.5.1 注意：使用消炎鎮痛劑治療，乃為對症療法非原因療法。

- 5.5.2 使用於治療慢性疾患（慢性風濕性關節炎、僵直性脊髓炎）時應考慮以下事項：

- A. 長期投與時，須定期作臨床檢查（尿檢查、血液檢查、肝功能檢查）遇有異常現象發生時，則須採取減量或停藥等適當措施。
- B. 考慮非藥物性療法。

- 5.5.3 使用於治療急性疾患時，應考慮以下事項：

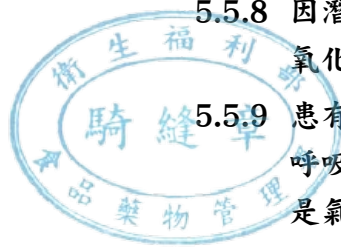
- A. 對於急性炎症須考慮其病痛及發熱程度而給藥。
- B. 原則上應避免長期使用同一類藥品。
- C. 如有原因療法則應採用。

- 5.5.4 須仔細觀察患者之狀況，留意有否副作用發生。

- 5.5.5 本藥可能遮蔽感染症狀之顯現，因此用於治療感染所引起之炎症時，必須合併使用適當之抗菌劑，同時仔細觀察，慎重投與。

- 5.5.6 儘量避免與其他消炎、鎮痛劑合併使用。

- 5.5.7 對以下患者須慎重投與：



- 5.5.8 因潛在的附加副作用，所以應避免同時使用Diclofenac與全身性的NSAIDs（包括環氧化酵素-2選擇性抑制劑）。
- 5.5.9 患有氣喘、季節過敏性鼻炎、鼻黏膜水腫（例如鼻息肉）、慢性阻塞性肺病或慢性呼吸道感染（特別是與過敏性鼻炎類似症狀相關時）的病患，對於NSAIDs的反應像是氣喘急速惡化（即對止痛劑或止痛劑-氣喘的不耐受性）、昆克水腫(Quincke's oedema)或蕁麻疹，比其他病患更常發生。因此對此類病患建議給予特殊的注意事項（緊急應變措施）。這也適用於對其他物質過敏（例如出現皮膚性反應、發癢或蕁麻疹）的病患。
- 5.5.10 對所有的NSAIDs藥物治療，務必進行嚴密的醫療監測，而且在開立Diclofenac處方治療有胃腸疾病症狀或有胃腸潰瘍、出血或穿孔病史（詳見8. 副作用／不良反應章節）的病患時，尤其須特別注意。胃腸出血的風險會隨著NSAID劑量的增加、潰瘍的病史（特別是併發出血或穿孔）及年長的病患而提高。
- 5.5.11 為降低曾經患有潰瘍、特別是併發出血或穿孔及年長病患的胃腸毒性，治療應該以最低有效劑量開始並維持在該劑量。這些病患應該考慮以保護劑（例如質子幫浦抑制劑或misoprostol）併用的療法治療，亦適用於需要併用含低劑量阿斯匹靈(ASA/aspirin)的藥物或其他可能增加胃腸風險的藥物之病患。
- 5.5.12 具有胃腸毒性病史的病患，特別是年長的病患，如有任何不尋常的腹部症狀（特別是胃腸出血），應該立即通報。病患接受可能增加潰瘍或出血的併用藥物（例如全身性類固醇、抗凝血、抗血小板劑或選擇性血清素再吸收抑制劑）時，應小心謹慎使用（請參照7. 交互作用章節）。
- 5.5.13 皮質類固醇藥物治療：Diclofenac不能取代皮質類固醇或治療皮質類固醇不足。貿然停用皮質類固醇可能造成皮質類固醇反應性疾病的惡化。長期接受皮質類固醇治療的病人，若決定停藥，應緩慢減低劑量。
- 5.5.14 Diclofenac抗發炎及退燒的藥理作用會降低利用這些診斷徵象來偵測感染性併發症發生於一些本來推論為非感染性疼痛情形的機會。
- 5.5.15 腸胃不適、有胃潰瘍病史、潰瘍性結腸炎或Crohn氏症、及肝功能不全之患者，必須在嚴密的監督下投予本品。
- 5.5.16 與其他NSAIDs一樣，本品可能導致一種或多種肝臟酵素值的升高；因此，在以Diclofenac長期治療期間，應注意監測患者之肝功能。如果肝功能異常現象持續不斷甚或惡化，或有臨床徵狀顯示產生肝臟疾病，或發生其他異常現象（如嗜伊紅血球增多、發疹等）時，應停用Diclofenac。患者也可能會毫無先兆地發生肝炎。
- 5.5.17 由於前列腺素對維持腎血流極為重要，對下列患者投予本品時應特別注意：心臟或腎臟功能不全、老年病患、正服用利尿劑者，或任何原因（如重大手術前後）導致之細胞間液排空。對這類患者投予Diclofenac時，應特別注意監測其腎功能。停止治療後，通常會恢復到治療前的狀況。
- 5.5.18 與其他NSAIDs一樣，Diclofenac可能會暫時地抑制血小板凝集，因此，凝血不全之患者應予以小心監測。

6 特殊族群注意事項

（依文獻記載）

6.1 懷孕

6.1.1 Diclofenac可能導致胎兒動脈導管過早閉合，因此於懷孕後期應避免使用。

6.1.2 對孕婦之安全性尚未建立。一些流行病學研究指出，在妊娠早期使用前列腺素合成抑制劑（如NSAID）後，流產、心臟畸形、腹裂(gastrochisis)的風險增加。對於孕婦及可能懷孕之婦女，須判斷其治療效益超過危險性時，方予投與。

6.1.3 像其他NSAIDs一樣，懷孕第三期婦女禁用本藥，因可能造成子宮收縮無力、胎兒腎功能不全伴隨羊水過少及/或胎兒動脈導管閉鎖過早。

6.1.4 Pregnancy Category（懷孕用藥級數）：C

6.1.5 抑制前列腺素合成可能會影響懷孕和／或胚胎／胎兒發育。部分流行病學研究數據顯示，在懷孕早期使用前列腺素合成酶抑制劑會提高流產、心臟畸形之風險。動物實驗已證實使用前列腺素合成酶抑制劑會導致著床前／後胚胎損失率及胚胎／胎兒致死率增加；此外，曾有動物實驗報告指出，於器官形成期使用前列腺素合成酶抑制劑之動物，其胚胎畸形（包括心血管畸形）之發生率增加。

6.2 哺乳

Diclofenac與其他NSAIDs一樣，會少量出現於母乳中。因此，為了避免對嬰兒有不良影響，哺乳期間不應使用Diclofenac。

6.3 有生育能力的女性與男性

6.3.1 生育可能婦女：目前尚未有資訊提供給生育可能之婦女。

6.3.2 生育能力：如同以其他NSAIDs的治療，Diclofenac可能會損害女性的生育能力，因此不建議使用於想要懷孕的婦女。對於懷孕很困難的婦女或進行生育能力研究的婦女，應該考慮停止Diclofenac的治療。

6.4 小兒

兒童使用Diclofenac的安全性及有效性尚未建立。

對小兒患者，尤其注意有否副作用出現，並以最低之有效劑量來慎重投予。

6.5 老年人

臨床研究中老年與年輕受試者之有效性或安全性並無整體差異，然而不能排除某些老年人會對非類固醇類消炎藥的作用更加敏感。由於老年人的腎功能可能較差，在使用Diclofenac時須特別注意監測腎功能。

對高齡患者，尤其注意有否副作用出現，並以最低之有效劑量來慎重投予。

基本上，對老年患者之用藥，本就應加小心。特別是對身體虛弱或體重過輕之老年患者，建議應使用最低有效劑量。

6.6 肝功能不全

對肝性血紅素生成失調(hepatic porphyria)之患者投予Diclofenac時，因可能導致發病，故應多加小心。

7 交互作用

以下所列，亦包括自其他Diclofenac劑型觀察而得之交互作用。

已觀察到需注意之交互作用



CYP2C9抑制劑：同時處方Diclofenac與CYP2C9抑制劑（例如：voriconazole）應特別注意，CYP2C9抑制劑可能抑制Diclofenac之代謝，顯著地增加Diclofenac之最高血漿濃度及暴露量。

與含有鋰和毛地黃苷(Digoxin)製劑一起治療時提高本藥物的血漿濃度，但在這種情況下還未見到超過劑量的臨床徵兆。

鋰鹽(Lithium)：非類固醇類消炎藥可能提高鋰鹽的血漿中濃度及降低其腎排除。合併使用期間應密切觀察是否有鋰鹽中毒之徵象。

毛地黃：假如同時使用，Diclofenac可能會提高血漿中毛地黃的濃度。因此建議監測血清中毛地黃的濃度。

利尿劑及抗高血壓藥物：與其他的NSAIDs一樣，若Diclofenac與利尿劑或抗高血壓藥物（例如β阻斷劑、血管收縮素轉化酶(ACE)抑制劑）一起使用，可能會導致其抗高血壓的藥效減少，因此合併使用務必小心，且病患（特別是年長者）應該定期監測血壓。病患在初次使用合併療法後應該充分補充水分，並且在日後定期接受腎臟功能的監測，特別是針對利尿劑及ACE抑制劑（因腎臟毒性的風險增加之故）。臨床研究指出，有些病人在同時接受非類固醇類消炎藥治療時，會使得furosemide及thiazides的利鈉尿作用減弱。合併使用期間應密切觀察是否有腎衰竭之徵象，並確保利尿劑之效用。

ACE抑制劑：非類固醇消炎藥會減弱血管張力素轉換酶[angiotensin converting enzyme (ACE)]抑制劑的降血壓作用。同時投予非類固醇類消炎藥與ACE抑制劑時應考慮二者之間可能發生之交互作用。

Ciclosporin環孢素及tacrolimus：Diclofenac和其他的NSAIDs一樣，可能會因為環孢素及tacrolimus對腎臟前列腺素的影響而增加腎毒性，因此應該給予比未服用環孢素及tacrolimus病患還低的劑量。

併用已知會造成高血鉀症(hyperkalemia)的藥物，如：保鉀型利尿劑、ciclosporin、tacrolimus或trimethoprim，可能會增加血鉀濃度。因此，應持續監測血鉀濃度。

Quinolone類抗生素：曾有報告指出，少數痙攣病例可能是導因於Quinolones與NSAIDs之併用。

可預期發生需注意之交互作用

其他NSAIDs及皮質類固醇：Diclofenac與其他全身性NSAIDs藥物或皮質類固醇藥物合併使用可能會增加胃腸副作用發生的頻率（請參照5.1. 警語／注意事項及5.5. 其他注意事項章節）。

抗凝血劑與抗血小板劑併用：抗凝血劑與抗血小板劑合併使用可能會增加出血的風險，所以應小心謹慎。（請參照5.1. 警語／注意事項及5.5. 其他注意事項章節）。本藥物不會影響口服抗凝血劑的效用，但為了有利於預防，建議若同時服用本藥物和抗凝血劑應作有關實驗室檢查，以保持抗凝血劑有足夠的療效。抗凝血劑（如warfarin）與非類固醇類消炎藥對胃腸道出血的影響是加成性的，合併使用這兩類藥品的病人發生嚴重胃腸道出血之風險較單獨使用任一類藥品者為高。

選擇性血清素再吸收抑制劑(SSRIs)：全身性NSAIDs與SSRIs藥物合併使用可能會增加胃腸出血的風險（請參照5.1. 警語／注意事項及5.5. 其他注意事項章節）。

降血糖劑：臨床試驗顯示，Diclofenac可與口服降血糖劑併用，而不會影響其療效。然而，也曾有在以Diclofenac治療期間，因血糖降低或升高而須調整降血糖劑劑量之個別病例報告。曾有個別報告指出，Diclofenac與metformin併用發生代謝性酸中毒，特別是在已有腎臟損傷之病患。

Phenytoin：同時使用phenytoin與Diclofenac，建議監測血漿中phenytoin的濃度，因預期phenytoin之暴露量會增加。

Methotrexate：在投予Methotrexate的前、後24小時內使用Diclofenac，應加小心，因可能會升高Methotrexate的血中濃度，而導致其毒性增加。

CYP2C9誘導劑：同時處方Diclofenac與CYP2C9誘導劑（例如：rifampicin）應特別注意，CYP2C9誘導劑可能導致Diclofenac之血漿濃度及暴露量顯著下降。

Aspirin：由於可能增加不良反應（包括腸胃道出血）發生的風險，一般而言不建議同時使用aspirin與Diclofenac進行治療。

8 副作用/不良反應

（依文獻記載）

8.1 臨床重要副作用/不良反應

使用Diclofenac治療之病人較為常見的不良反應為胃腸道的影響，包括腹痛、便秘、腹瀉、消化不良、脹氣、大出血／穿孔、心灼熱感、噁心、胃腸道潰瘍（胃／十二指腸）與嘔吐。其他反應包括腎功能異常、貧血、頭暈、肝酵素升高、頭痛、延長出血時間、搔癢、紅疹及耳鳴。

曾在治療期間被報告過的不良反應包括：

全身：發燒、感染、敗血症。

心血管系統：充血性心衰竭、高血壓、心搏過速、暈厥。

消化系統：口乾、食道炎、胃／腸潰瘍、胃炎、胃腸出血、舌頭發炎、吐血、肝炎、黃疸。

血液及淋巴系統：瘀血、嗜伊性白血球增多、白血球過低、黑便、紫斑、直腸出血、口腔炎、血小板過低。

代謝及營養：體重改變。

神經系統：焦慮、衰弱、精神錯亂、憂鬱、作夢異常、睏倦、失眠、疲倦、緊張、感覺異常、嗜睡、顫抖、眩暈。

呼吸系統：氣喘、呼吸困難。

皮膚及附屬組織：禿髮、光敏感、排汗增加。

特殊器官：視力模糊。

泌尿系統：膀胱炎、排尿困難、血尿、間質性腎炎、少尿／多尿、蛋白尿、腎衰竭。

其他少見之不良反應包括：

全身：過敏反應、食慾改變、死亡。

心血管系統：心律不整、低血壓、心肌梗塞、心悸、血管炎、Kounis症候群（頻率尚未知）。

消化系統：結腸炎、噯氣、肝衰竭、胰臟炎。

血液及淋巴系統：顆粒性白血球缺乏、溶血性貧血、再生不良性貧血、淋巴結病變、全血球減少。

代謝及營養：高血糖。

神經系統：痙攣、昏迷、幻覺、腦膜炎。

呼吸系統：呼吸抑制、肺炎。

皮膚及附屬組織：血管性水腫、毒性表皮壞死溶解、多型性紅斑、剝落性皮膚炎、史蒂文生氏-強生症候群、蕁麻疹。

特殊感官：結膜炎、聽覺受損。

8.2 臨床試驗經驗

目前尚無資訊。

9 過量

(依文獻記載)

對非類固醇抗炎劑(包含Diclofenac)的急性中毒處理,須進行支持療法和症狀測定,因其典型臨床症狀尚未建立。用藥過量時應儘快採取洗胃和活性炭處理方法以阻止其被吸收;如攝取危及生命的過度劑量,可以進行胃除污(例如嘔吐及洗胃)。

用藥過量會造成類似嘔吐、胃腸出血、腹瀉、暈眩、耳鳴或痙攣的症狀。如有顯著毒性的現象,則可能造成急性腎衰竭與肝臟損傷。

對併發症,例如血壓過低、腎衰竭、痙攣、胃、腸刺激、呼吸抑制,應進行支持療法和症狀處理。由於非類固醇抗炎劑具高度蛋白結合率及廣泛的代謝,因此強迫利尿、透析、輸血等方式,並無助於促這類藥物的排除。

Diclofenac過量之症狀通常侷限於嗜睡、疲倦、噁心、嘔吐及上腹痛,一般予以支持性照護後可恢復。另可能發生胃腸道出血、高血壓、急性腎衰竭、呼吸抑制和昏迷。服藥過量時亦可能發生類過敏反應。

若有Diclofenac過量並導致顯著全身性副作用時,建議採取催吐或洗胃。除支持性措施外,口服活性炭可能幫助減低Diclofenac的吸收。對於併發症如腎衰竭、痙攣、胃腸道刺激及呼吸抑制等,應給予支持療法與症狀處理。

10 藥理特性

(依文獻記載)

10.1 作用機轉

Diclofenac Potassium含有Diclofenac的鉀鹽,為一非類固醇具有鎮痛,抗炎和解熱性能之成分。

其作用機轉為抑制前列腺素的合成。而前列腺素在形成發炎、疼痛與發燒過程中扮演著主要的角色。

體外試驗中,與人體內相同濃度的Diclofenac,並不會抑制軟骨中蛋白多醣(proteoglycan)的合成。

10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊。

10.3 臨床前安全性資料

Diclofenac的急性及重複劑量毒性與基因毒性、突變性與致癌性的臨床前試驗資料顯示,在建議劑量下,對人類並無專一性的傷害。標準臨床前動物試驗中,對老鼠及兔子均未見有致畸胎性。

Diclofenac不會影響動物(老鼠)母體之生育能力。除在母體的毒性劑量下胎兒有微小的影響,胎兒在懷孕前、中及後期的發展並不受影響。

施用NSAID (包括Diclofenac) 會抑制兔子的排卵以及大鼠的胚胎著床與胎盤形成，而導致懷孕大鼠發生早發性動脈導管閉鎖。Diclofenac的母體毒性劑量可能與大鼠難產、孕期過長、胎兒存活率降低以及子宮內生長遲滯有關。這是由於Diclofenac這類前列腺素合成抑制劑的藥理作用對生殖參數、分娩以及子宮內動脈導管窄縮所造成的輕微影響。

11 藥物動力學特性

(依文獻記載)

吸收

Diclofenac Potassium錠劑中的Diclofenac可迅速而完全地被吸收。投藥後吸收迅速且其吸收總量與同劑量之Diclofenac sodium腸溶錠相當。

口服50毫克錠劑20至60分鐘達到最高血中濃度 $3.8 \mu\text{mol/L}$ 。若與食物一起服用，主成分的吸收量不會減少，吸收速度可能較慢。

由於Diclofenac首次通過肝臟時，有半數會代謝掉 (首渡效應)，口服或以栓劑投予後之血漿濃度曲線下面積(AUC)，約為注射投予相等劑量時的一半。

重覆投予後，其藥動學特性並不會改變。按建議劑量間隔給藥，並未觀察到蓄積的現象。

分佈

超過99.7%的Diclofenac會與血漿蛋白結合，主要是與白蛋白結合(99.4%)。擬似分佈體積為 $0.12 \sim 0.17 \text{ L/kg}$ 。

Diclofenac會進入關節腔滑液，並可於達到最高血漿濃度2~4小時後，測得最高滑液中濃度。於滑液中的排除半衰期為3~6小時；在達到最高血漿濃度2小時後，滑液中活性成分的濃度已高於血漿濃度，此現象可持續達12小時。

一名授乳婦女的母乳中曾偵測出低濃度的Diclofenac (100 ng/mL)。嬰兒從母乳所攝取的估計劑量相當於 0.03 mg/kg/day 。

代謝

Diclofenac的代謝作用，一部分是直接形成尿甘酸結合物(glucuronidation)；但主要則是經單羥化(single hydroxylation)、多羥化(multiple hydroxylation)及甲氧基化(methoxylation)，形成多種酚基代謝物 (3'-hydroxy-, 4'-hydroxy-, 5'-hydroxy-, 4',5'-dihydroxy-, 及 3'-hydroxy-4'-methoxy diclofenac)，而其中多數會再轉化成尿甘酸結合物。這些酚基代謝物中，有兩種具生物活性，但其活性較Diclofenac低。

排泄

Diclofenac全身清除率為 $263 \pm 56 \text{ mL/min}$ ，最終血漿半衰期為1~2小時。有4種代謝物 (包括2種活性代謝物)，其血漿半衰期也很短，為1~3小時。代謝產物3'-hydroxy-4'-methoxy diclofenac有較長的血漿半衰期，但此代謝物幾乎不具活性。

Diclofenac經代謝後，約投予劑量的60%由尿液以尿甘酸結合物及其代謝物排出，其中多數代謝物會再轉化成尿甘酸結合物。小於1%以原型藥物排出體外。其餘部分則以代謝物型態經膽汁自糞便排除。

線性 / 非線性

藥物吸收量與劑量呈線性關係。

特殊病患群

老年病患：已知本品之吸收、代謝及排除與年齡無關。但少數的老年病患靜脈輸注15分鐘，最高血漿濃度比年輕健康受試者高50%。

腎功能不全病患：對腎功能不全之患者投予一般劑量時，由其單一劑量動力學可知，並不會產生原型活性成分蓄積的現象。對creatinine清除率 $< 10 \text{ mL/min}$ 之患者，其羥化代謝物之穩定血漿濃度約為正常人的四倍；然而，這些代謝物最後會經由膽汁排除。

肝功能不全病患：對慢性肝炎或非代償不全肝硬化之患者，Diclofenac的動力學及代謝與未患有肝病者相同。

12 臨床試驗資料

(依文獻記載)
目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

4~1000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

13.2 效期

如外包裝標示。

13.3 儲存條件

於25°C以下、避光儲存。

13.4 儲存注意事項

本藥應置於小兒伸手不及處。
請在有效期限內使用。

製造廠

永信藥品工業股份有限公司台中幼
獅廠

台中市大甲區日南里工九路27號

藥商

永信藥品工業股份有限公司

台中市大甲區頂店里中山路一段1191號